

ORIGINAL

Calidad de atención en salud percibida por los pacientes en un centro de salud urbano de A Coruña

María Inmaculada Gómez-Besteiro^{a,*}, Jorge Somoza-Digón^b, Margot Einöder-Moreno^c,
Maria Noelia Jiménez-Fraga^d, Susana Castiñeira-Pereira^e y María Luisa Feijoo-Fuentes^f

^a Xerencia de Atención Primaria, Escuela Universitaria de Enfermería (UDC), SERGAS, A Coruña, España

^b Urgencias Sanitarias de Galicia 061, SERGAS, Santiago, España

^c Complejo Hospitalario Montecelo, SERGAS, Pontevedra, España

^d Centro de Salud Os Mallos, SERGAS, A Coruña, España

^e Hospital Virxen da Xunqueira, SERGAS, Cee, España

^f Centro de Salud Adormideras, SERGAS, A Coruña, España

Recibido el 9 de noviembre de 2011; aceptado el 11 de abril de 2012

Disponible en Internet el 1 de junio de 2012

PALABRAS CLAVE

Calidad percibida;
Servicio de salud;
Atención primaria

Resumen

Objetivos: Explorar la fiabilidad y validez del cuestionario adaptado SERVPERF en el ámbito de atención primaria y obtener una medida de la calidad de atención en salud desde la perspectiva de los pacientes en un centro de salud (C. S.).

Diseño: Estudio descriptivo transversal.

Participantes: Del total de los pacientes que acudieron a consultas al centro de salud durante una semana de marzo de 2010 se seleccionó de forma sistemática uno de cada 5, hasta completar el tamaño muestral requerido.

Mediciones principales: Para medir la calidad de atención en salud percibida se utilizó la encuesta adaptada SERVPERF, con 22 ítems medidos en escala Likert (1-7), a la que se añadieron 3 preguntas abiertas y variables personales.

Resultados: Participaron un total de 132 pacientes con una edad media de 50 años (rango 16-89), el 67% eran mujeres. La encuesta con los 22 ítems mostró una consistencia interna α -Cronbach=0,90 (IC 95%: 0,87-0,93) y en cada una de las 5 dimensiones este valor estuvo entre (0,71-0,90). El análisis factorial señaló 5 factores que explicaron un 69,83% de la varianza.

La puntuación total media obtenida fue de $123,22 \pm 16,95$, el ítem mejor valorado fue el «Seguimiento individualizado por el médico de cada paciente» con una media de $6,66 \pm 0,79$ (IC: 6,53-6,79).

Conclusiones: El cuestionario utilizado (SERVPERF adaptado) se mostró fiable y válido para medir percepción de calidad de la atención sanitaria en atención primaria. Los pacientes consideraron que el servicio de atención sanitaria que recibieron fue de buena calidad.

© 2011 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: maria.gomez.besteiro@udc.es (M.I. Gómez-Besteiro).

KEYWORDS

Perceived quality;
Health service;
Primary care

Health care quality perceived by the patients in an urban health centre in a coruña**Abstract**

Objective: The aim of this study is to explore the reliability and validity of the adapted questionnaire SERVPERF in primary care and to obtain a measure of perceived quality from the patient point of view in an urban health centre.

Method: A cross-sectional descriptive study.

Participants: One in five of all the patients who visited the health centre during one week in March 2010 were systematically selected until completing the required sample size.

Main measurements: Personal data were collected (age, sex, nationality, marital status, level of studies, working status and their own perception on their health status). To measure the perceived quality the adapted questionnaire SERVPERF was used, with 22 items measured using a Likert scale (1-7), to which was added three open questions.

Results: Out of a total of 132 patients, 67% of those who completed the questionnaire were women. All the interscale correlations were positive and significant. The overall statistical value for Cronbach's- α was equal to 0.90 (95% CI: 0.87-0.93), and in all domains this value ranged from 0.71 to 0.90. The factor analysis identified 5 factors that explained 69.8% of the total variance. Of the studied items, the "Individualized follow up of each patient by the doctor", with an average of 6.66 ± 0.79 (95% CI: 6.53-6.79), was the best valued.

Conclusions: The questionnaire (adapted SERVPERF) is reliable and valid for measuring perceived quality in primary care, and patients felt that the service offered is of good quality.

© 2011 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Qué se conoce

La percepción de los clientes-usuarios es importante para evaluar la calidad de los servicios de salud y poder instaurar correcciones o mejoras. El SERVQUAL y SERVPERF son instrumentos pioneros para medir de forma cuantitativa la calidad percibida de servicios en general.

En el sector de servicios de salud abundan trabajos que evalúan el punto de vista del paciente con instrumentos de elaboración propia (cuestionarios), en pocos casos validados y que difícilmente permiten comparaciones.

El cuestionario adaptado por Díaz¹¹ del SERVPERF (22 ítems), con población general usuaria de sanidad pública versus privada mostró buenas propiedades psicométricas.

Qué aporta

Confirma en usuarios de atención primaria las buenas propiedades psicométricas del cuestionario SERVPERF adaptado por Díaz¹¹.

Con igual número de factores explica un mayor porcentaje de varianza, consigue más homogeneidad en los contenidos de cada factor y además define un factor único con enfermería.

Introducción

En las últimas décadas los servicios sanitarios se ven inmersos, como cualquier organización, en el modelo vigente de Gestión de Calidad Total (GCT, en inglés TQM). Este modelo se centra en satisfacer las expectativas del cliente y tiene como finalidad la búsqueda de la mejora continua, una alta competitividad y la satisfacción tanto del cliente externo como interno¹.

Para ayudar a las organizaciones a conocerse y mejorar su funcionamiento, se ha desarrollado, entre otros, el modelo de Excelencia European Foundation for Quality management (EFQM), modelo de autoevaluación con criterios que permiten analizar personas, procesos y resultados de la organización. Entre los criterios de resultados está la percepción que los clientes tienen de la calidad de la organización, medida a través de encuestas o contactos directos^{1,2}.

Sin embargo, definir y medir la calidad de los servicios sanitarios no es tarea fácil; ya que los usuarios de los servicios (clientes) valoran sobre todo la competencia o el comportamiento del personal; los proveedores (profesionales sanitarios) la basan en los conocimientos y en la tecnología empleada, y los responsables de la gestión la definen en relación con la eficiencia del personal y de las instalaciones³.

Así, el concepto de calidad de atención de salud percibida implica un importante cambio metodológico, ya que supone trasladar la valoración de la calidad del servicio de criterios objetivos hacia criterios subjetivos. Existe consenso en la comunidad científica en que deben medirse al menos los siguientes aspectos: a) aspectos técnicos-científicos (la calidad técnica; es un resultado y se refiere a lo que recibe el cliente), b) aspectos de relación interpersonal (calidad funcional, relacionada con el proceso; es decir, cómo lo recibe). También son importantes otros aspectos sobre

las condiciones en las que se presta la atención, como confort, información, rapidez o amabilidad (calidad de la estructura)³⁻⁶.

A menudo en los artículos se utilizan como sinónimos términos relacionados, tales como: satisfacción, expectativas, necesidades, calidad percibida, etc.

Algunos autores definen la satisfacción como la medida en que la atención recibida cumple las expectativas debido a la estrecha relación que existe entre la satisfacción de los usuarios de servicios sanitarios y el cumplimiento o no de sus expectativas⁷⁻⁹.

Lijander sugiere que los modelos de satisfacción pueden ser denominados «*de calidad de servicio percibida*»⁵.

La satisfacción del usuario-paciente y la percepción de calidad en relación con la atención recibida son resultado de la interacción de muchos factores, aunque es muy difícil determinar el peso específico de cada uno de ellos¹⁰. Algunos muestran cómo la percepción de la calidad de un servicio sanitario se modifica en función de determinadas características de los pacientes, tales como: edad, situación socio-económica, estado de salud, presencia de enfermedades crónicas, utilización de servicios, etc.⁶; la satisfacción es considerada incluso un buen predictor del cumplimiento terapéutico por parte de los pacientes, que propicia la adhesión al proveedor de servicios y sirve de instrumento para orientar las mejoras de las organizaciones sanitarias^{4,11-13}.

Los 2 instrumentos pioneros para medir de forma cuantitativa la calidad de servicios en general son los cuestionarios *SERVQUAL* y *SERVPERF*, diseñados por Parasuraman et al. (1988) y por Cronin et al. (1992) respectivamente^{2,3,14}.

El *SERVQUAL* contiene 44 ítems divididos en 2 escalas, de las que una mide expectativas y otra percepciones. El *SERVPERF* (Service-Performance) utiliza la escala de percepciones del *SERVQUAL* e incorpora una batería de cuestiones en las que se recoge la importancia que los usuarios conceden a cada ítem.

Metodológicamente la escala *SERVPERF* aporta mejoras sobre la escala *SERVQUAL*, porque reduce el número de ítems a la mitad y se encontró que es un instrumento más adecuado para explicar la calidad global de un servicio¹⁴.

La continuidad y la accesibilidad de la atención en salud, y en relación con ellas, una relación médico-paciente basada en la confianza y en la toma de decisiones compartidas, son factores nucleares en atención primaria¹⁵⁻¹⁷.

Este estudio se realiza con los objetivos de explorar la fiabilidad y validez del cuestionario adaptado *SERVPERF*¹¹ en el ámbito de atención primaria y obtener una medida de la calidad de la atención en salud desde la perspectiva de los pacientes en un Centro de Salud (C. S.) de A Coruña.

Método

Diseño: estudio descriptivo transversal.

Ámbito: el estudio se realizó en un centro de salud de atención primaria del área urbana de la ciudad de A Coruña con una población asignada de 6.760 personas.

Sujetos: sobre el total de consultas a demanda de adultos en la semana previa al estudio se estimó, con un nivel de confianza del 95% y una proporción esperada del 50%, un tamaño muestral necesario de $n_1 = 130$, que en previsión de no respuestas se aumentó un 18% ($n_2 = 158$).

De las consultas a demanda de adultos, durante una semana de lunes a viernes, se seleccionó de forma sistemática uno de cada 5 pacientes, hasta completar el tamaño muestral estimado.

Instrumento de medida

1. Cuestionario adaptado de la escala *SERVPERF* validado por Díaz¹¹ en el ámbito sanitario con usuarios de servicios sanitarios públicos versus servicios sanitarios privados (fig. 1), compuesto por 22 ítems que miden el grado de calidad percibida con el servicio sanitario en una escala Likert de 7 puntos (1 nivel más bajo de calidad percibida-7 nivel más alto). Los 22 ítems componen 5 dimensiones de calidad percibida que son: Atención recibida por el personal médico, (8 ítems: P1-P8), Atención recibida por el personal administrativo y de enfermería, (4 ítems: P9-P12), Organización, (4 ítems: P13-P14, P18-P19), Elementos tangibles, (3 ítems: P15-P17) y Tiempo de espera (3 ítems: P20-P22).
2. Un ítem de valoración subjetiva de la propia salud (escala 1-5: 1 mala-5 excelente).
3. Tres preguntas abiertas para expresar lo que gusta más y menos del centro de salud y cómo se podría mejorar.
4. Variables sociodemográficas: edad, sexo, nacionalidad, estado civil, nivel de estudios y situación laboral.

Recogida de los datos

En las salas de espera, antes de que los pacientes entrasen a las consultas del médico de familia, 2 encuestadoras entrenadas invitaban a participar en el estudio a los seleccionados. Tras firmar el consentimiento informado les entregaban la encuesta, que debían cubrir y depositar posteriormente en un cajón colocado para este estudio.

Análisis de los datos

Se determinó distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, con intervalos de confianza de 95%. Para la comparación entre variables cualitativas, se utilizó la prueba de Ji-cuadrado y para las variables cualitativas-cuantitativas la prueba t-Student o U de Mann-Whitney según siguiesen o no una distribución normal. Se calculó el α -Cronbach para estimar la consistencia interna y se determinó el análisis factorial con rotación Varimax^{18,19}. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 17.0 y EPIDAT 3.1.

Resultados

Características de los participantes

Los 158 pacientes invitados a participar firmaron el consentimiento informado, de los cuales 132 entregaron el cuestionario cumplimentado, lo que supuso un índice de respuesta de 83,5%. Un 66,9% fueron mujeres.

La edad media de los participantes fue de 50 años ($\pm 15,97$); el más joven de 16 años y el mayor de 89 años. La

Por favor valore las siguientes características de la atención recibida en su centro de salud.
 Marque con una X..... (1=peor valoración7=mejor valoración)

P1. - Preparación de los médicos para atender a los problemas de salud de los pacientes (conocimientos, habilidades y experiencia).	1	2	3	4	5	6	7
P2. - Confianza transmitida por los médicos.	1	2	3	4	5	6	7
P3. - Realización del servicio correctamente a la primera por parte del médico.	1	2	3	4	5	6	7
P4. - Claridad con que el médico informa al paciente.	1	2	3	4	5	6	7
P5. - Seguimiento individualizado por el médico de cada paciente.	1	2	3	4	5	6	7
P6. - Amabilidad de los médicos.	1	2	3	4	5	6	7
P7. - Interés demostrado por los médicos para solucionar el problema de salud de los pacientes.	1	2	3	4	5	6	7
P8. - Disposición de los médicos para prestar el servicio de inmediato.	1	2	3	4	5	6	7
P9. - Amabilidad del personal de enfermería.	1	2	3	4	5	6	7
P10. - Amabilidad del personal no sanitario (información, administración, etc.).	1	2	3	4	5	6	7
P11. - Preparación del personal de enfermería.	1	2	3	4	5	6	7
P12. - Preparación del personal no sanitario (administrativos).	1	2	3	4	5	6	7
P13. - Coordinación entre niveles asistenciales (atención primaria y atención especializada).	1	2	3	4	5	6	7
P14. - Tiempo dedicado por el personal sanitario.	1	2	3	4	5	6	7
P15. - Apariencia del equipo médico.	1	2	3	4	5	6	7
P16. - Aspecto de las instalaciones.	1	2	3	4	5	6	7
P17. - Aspecto físico del personal.	1	2	3	4	5	6	7
P18. - Facilidad de trámites y papeles.	1	2	3	4	5	6	7
P19. - Facilidad de acceso al servicio (horarios, cercanía del centro, aparcamientos, etc.).	1	2	3	4	5	6	7
P20. - Tiempo transcurrido para dar una cita.	1	2	3	4	5	6	7
P21. - Tiempo transcurrido para realizar pruebas complementarias (análisis, radiografías, etc.).	1	2	3	4	5	6	7
P22. - Tiempo transcurrido para ser intervenido quirúrgicamente.	1	2	3	4	5	6	7

Figura 1 Cuestionario SERVPERF adaptado (22 ítems).

distribución por grupos de edad, nacionalidad, estado civil y nivel educacional se muestra en la [tabla 1](#).

Consistencia interna α -Cronbach y correlaciones inter-escalares

El cuestionario SERVPERF adaptado, con 22 ítems, mostró una consistencia interna α -Cronbach = 0,90 (IC: 0,87-0,93). Los valores obtenidos de consistencia interna para cada una de las dimensiones y las correlaciones interescalares se muestran en la [tabla 2](#).

Análisis factorial

Al aplicar el análisis factorial con los 22 ítems se obtuvieron 5 factores con autovalores >1 que explicaron un 69,83% de la

varianza total. La matriz de los componentes tras la rotación Varimax, el nombre dado a los factores y la descripción del contenido de los ítems se muestra en la [tabla 3](#).

Descripción general de la puntuación total e ítems individuales

La puntuación media total ($\sum$ 22 ítems) fue de $123,22 \pm 16,95$ (rango 61-154). Las puntuaciones medias de cada uno de los ítems con sus intervalos de confianza (95%) se muestran en la [figura 2](#).

Puntuaciones según sexo y grupos de edad

Las mujeres obtuvieron una puntuación total media superior a los hombres ([tabla 4](#)) y también en cada uno de los 22

Tabla 1 Distribución de frecuencias de las variables sociodemográficas edad, nacionalidad, estado civil y nivel de estudios según sexo

	Mujeres	Hombres	Total	%	IC (95%)
Grupos de edad					
≤ 29 años	11	5	16	12,6	(6,4–18,8)
30 - 49 años	33	12	45	35,5	(26,7–44,1)
50 - 69 años	34	18	52	40,9	(31,9–49,9)
≥ 70 años	7	7	14	11,0	(5,2–16,9)
Total	85	42	127	100,0	
Nacionalidad					
Española	81	40	121	98,4	(94,2–99,8)
Extranjera	2	0	2	1,6	(1,2–5,7)
Total	83	40	123	100,0	
Estado civil					
Soltero/vive solo	13	9	22	17,6	(10,5–24,7)
Casado/vive con	54	32	86	68,8	(60,3–77,3)
Separado/divorciado	6	1	7	5,6	(1,16–10,0)
Total	83	42	125	100,0	
Nivel de estudios					
Sin estudios	5	2	7	5,7	(1,2–10,2)
Primaria/secundaria	39	16	55	44,7	(35,5–53,9)
Bachillerato	15	14	29	23,6	(15,7–31,5)
Diplomatura-licenciatura	24	2	32	26,0	(17,8–34,2)
Total	83	40	123	100,0	

ítems; estas diferencias fueron significativas ($p \leq 0,03$) en: el factor 2 (Accesibilidad-organización) y en los siguientes ítems individuales: P5, P11, P16, P18, P19, P20, P21 y P22.

Los grupos de mayor edad mostraron una puntuación total media superior (tabla 3); la diferencia fue significativa ($p = 0,036$) entre el grupo de ≥ 70 años y el grupo de menor edad, ≤ 29 años. También se encontraron diferencias significativas ($p < 0,02$) entre estos grupos de edad para los factores 2, 3, 5 y con los ítems individuales P6, P9, P10 (refieren aspectos de amabilidad) P12 (preparación del personal no sanitario), P13 (coordinación entre niveles asistenciales) y P21 (tiempo transcurrido para realizar pruebas complementarias). Las puntuaciones más altas se obtuvieron en las mujeres de más edad y las puntuaciones más bajas por los hombres más jóvenes.

Valoración subjetiva del estado de salud

Los pacientes valoraron su propia salud de la siguiente manera: mala (3,9%), regular (26,8%), buena (53,5%), muy buena (14,2%) y excelente (1,6%).

Los pacientes refirieron peor estado de salud a medida que aumentaba la edad.

Los pacientes que percibieron su salud como mala-regular tenían una media de edad ($X1 = 54$ años $\pm 14,2$) significativamente superior ($p = 0,04$) a aquellos con una percepción buena-muy buena-excelente ($X2 = 48,2$ años $\pm 16,4$).

Los pacientes con mejor valoración subjetiva de su estado de salud fueron los que mejor valoraron la calidad del servicio. Sin embargo, al analizar según sexo, esta tendencia se invertía en los hombres, de tal forma que los que mostraban una mejor percepción de su propio estado de salud eran los que peor valoraban la calidad del centro.

Preguntas abiertas

A la pregunta *¿Qué es lo que más les gusta del centro de salud?* Respondieron con algún comentario 95 personas, un (72%); del análisis de sus contenidos emergieron 3 categorías: profesionalidad de los sanitarios, trato personal e

Tabla 2 Consistencia interna (α -Cronbach) y correlaciones interescales entre factores

	α -Cronbach	IC (95%)	F1	F2	F3	F4
Total (22 ítems)	0,90	0,87-0,93				
F1.-Personal médico	0,90	0,88-0,93				
F2.-Accesibilidad-organización	0,85	0,75-0,86	0,357*			
F3.- Personal no sanitario	0,81	0,74-0,86	0,403*	0,516*		
F4.-Aspecto y apariencia personal	0,71	0,59-0,80	0,553*	0,410*	0,364*	
F5.-Personal de enfermería	0,79	0,62-0,82	0,403*	0,401*	0,509*	0,436*

* $p < 0,01$.

Tabla 3 Matriz de componentes con rotación Varimax de los 22 ítems del cuestionario adaptado SERVPERF

Coeficientes factoriales de los ítems después de la rotación.					
	F1	F2	F3	F4	F5
<i>Personal médico</i>					
P7.-Interés por solucionar...	0,846	0,052	0,196	0,087	0,005
P8.-Disposición inmediata...	0,793	0,054	0,213	0,043	0,064
P2.-Confianza transmitida...	0,779	0,072	0,023	0,404	0,119
P3.-Servicio correcto a la primera...	0,749	0,076	0,300	0,277	-,087
P4.-Claridad con la que informa...	0,741	0,059	-,060	0,040	0,360
P6.-Amabilidad de los médicos	0,713	0,164	0,220	-,245	0,045
P1.-Preparación de los médicos...	0,683	-,060	0,112	0,388	0,009
P5.-Seguimiento individualizado...	0,677	0,275	-,210	0,045	0,179
P14.-Tiempo dedicado personal sanitario	0,534	0,215	0,155	0,379	0,329
<i>Accesibilidad-organización</i>					
P21.-Tiempo pruebas complementarias	0,015	0,851	0,120	0,138	0,031
P20.-Tiempo transcurrido dar una cita...	0,054	0,770	0,309	-,005	0,259
P22.-Tiempo transcurrido... para cirugía	-,093	0,726	0,016	0,209	0,230
P19.-Facilidad de acceso al servicio...	0,222	0,681	0,020	-,130	0,186
P16.-Aspecto de las instalaciones	0,197	0,671	0,163	0,150	-,054
P13.-Coordinación entre niveles...	0,161	0,563	0,468	0,343	-,089
<i>Personal no sanitario</i>					
P10.-Amabilidad personal no sanitario	0,136	0,117	0,803	0,045	0,351
P12.-Preparación personal no sanitaria...	0,135	0,225	0,794	0,110	0,293
P18.-Facilidad de trámites y papeles	0,289	0,442	0,607	0,136	-,039
<i>Aspecto personal</i>					
P15.-Apariencia del equipo médico	0,485	0,089	0,059	0,710	0,093
P17.-Aspecto físico del personal	0,080	0,326	0,175	0,704	0,215
<i>Personal de enfermería</i>					
P9.-Amabilidad de enfermería	0,124	0,130	0,346	0,046	0,784
P11.-Preparación de enfermería	0,216	0,273	0,170	0,263	0,746
<i>Autovalores sin rotar >1</i>	8,166	3,259	1,545	1,235	1,159

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 7 iteraciones

infraestructuras-accesibilidad. Para facilitar la comprensión se muestran fragmentos textuales en las categorías.

Profesionalidad de los sanitarios, fue la más numerosa, con citas como: «La doctora y la enfermera, su profesionalidad», «mi médico y enfermera», «la confianza en mi médico», «la Dra., una excelente profesional», «la eficacia y capacidad de Dra.», «eficiencia».

Trato personal: «amabilidad», «preocupación y cariño», «familiaridad en el trato», «factor humano».

Infraestructuras-accesibilidad: «cercanía al domicilio», «facilidad para el aparcamiento», «instalaciones».

¿Qué es lo que menos le gusta? Respondieron un 67%, las respuestas se agruparon en 2 categorías, la recepción administrativa y el tiempo de espera entre la hora de cita

Tabla 4 Puntuación total media ($\sum$ 22 ítems del cuestionario SERVPERF) según sexo y grupos de edad

Grupos de Edad	Puntuación total media ($\sum$ 22 ítems SERVPERF)					
	Total		mujeres		hombres	
	Media	D. E	Media	D. E	Media	D. E
≤ 29 años	115,5	17,3	118,6	18,1	107,0	13,4
30-49 años	121,6	19,3	124,4	20,1	115,1	16,3
50-69 años	124,3	13,2	125,9	14,3	121,9	11,1
≥ 70 años	133,8	15,6	136,6	17,1	131,5	15,3
Total	123,1	16,9	124,9	17,6	119,8	15,0

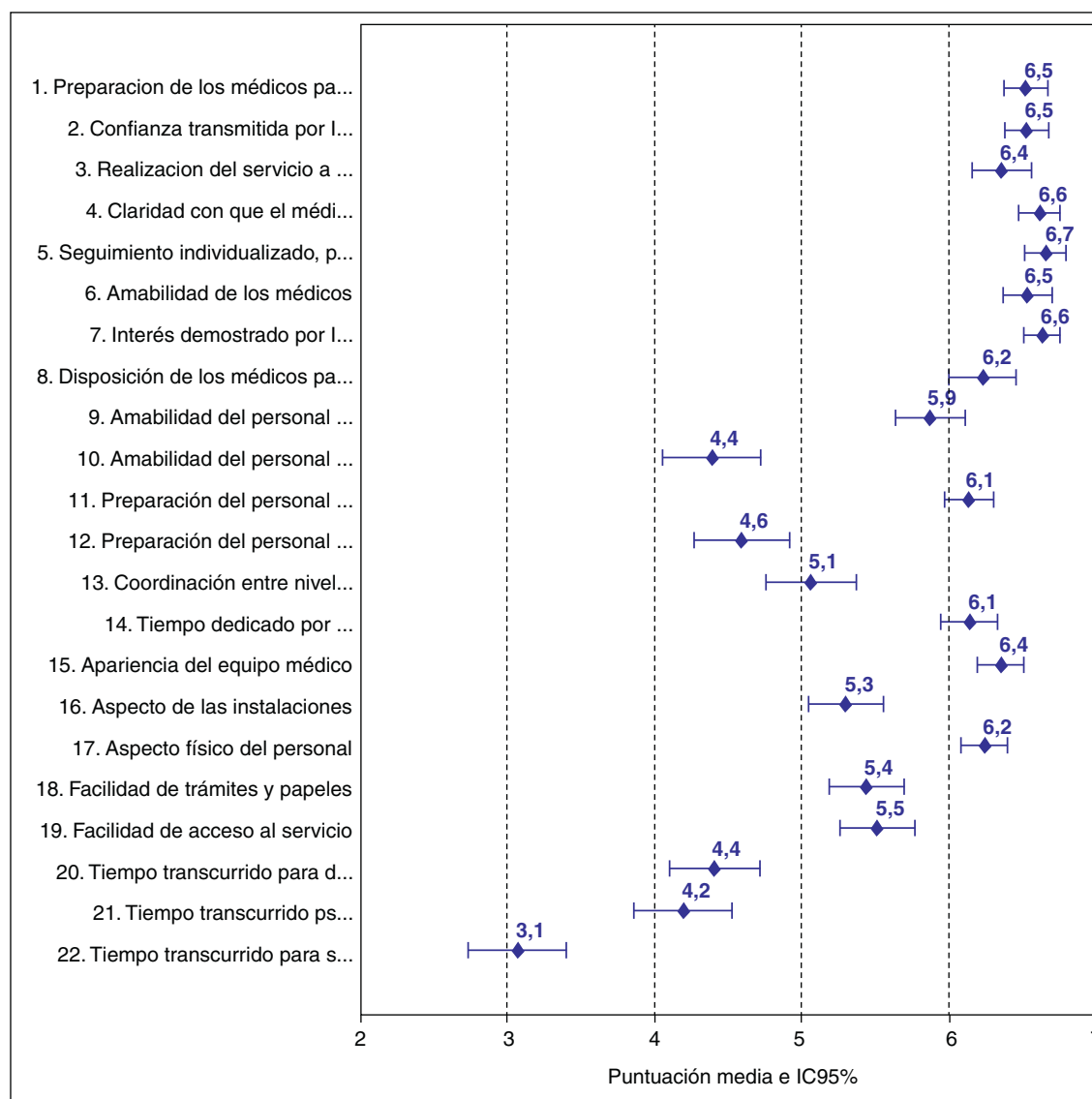


Figura 2 Puntuación media de los 22 ítems del cuestionario adaptado SERVPERF.

y la atención real. Los otros comentarios fueron muy heterogéneos para poder definir una categoría, algunos hacían referencia a aspectos organizativos y de estructura: «*horario solo de mañana*», «*cada vez que acudo al centro tengo un médico distinto*», «*escasez de médicos*», «*la sonoridad de las salas, se oye lo que dicen los pacientes*».

¿Cómo se podría mejorar? Respondieron un 53%, los aspectos mencionados se clasificaron en 2 categorías: aumentar recursos y mejorar la atención del servicio administrativo con citas del tipo de: «*aumentar el tiempo estipulado para tratar a cada paciente*», «*aumentos de plantilla y que las personas en recepción sean más amables*», «*establecer turno de tarde*».

Discusión

Los cambios introducidos en la asistencia sanitaria y de forma especial el hecho de considerar al paciente centro de atención de los procesos obliga a considerar en el

análisis de la calidad de los servicios la percepción de los usuarios^{11,20}. Los hallazgos de este estudio muestran la utilidad del instrumento adaptado del SERVPERF¹¹ para medir la calidad percibida por los usuarios en un servicio de atención primaria urbano.

Se obtiene un alto índice de participación (83%), superior a otros estudios^{21,22}, quizás porque nuestras encuestas se realizaron en la sala de espera, mientras los pacientes esperaban la consulta. Sin embargo debemos señalar que algunas personas, que habían entregado su consentimiento firmado, posteriormente no entregaron la encuesta cumplimentada. Este hecho podría haber introducido un sesgo, debido, entre otros motivos, a dificultades para entender el cuestionario, desacuerdo con los contenidos de la encuesta en general o incluso, como algún autor refiere¹⁵, ser un reflejo de la poca costumbre de los usuarios de servicios sanitarios para expresar sus percepciones de la calidad.

Las características sociodemográficas que obtenemos en nuestra muestra coinciden con los datos generales de la

población de usuarios del centro consultados en la Xerencia de atención primaria de A Coruña, y como muchos estudios de demanda en primaria reflejan una mayor proporción de mujeres^{15,21-23}.

La alta consistencia interna que obtenemos en la escala total y en cada una de las 5 dimensiones extraídas, junto con las correlaciones interescales nos permite estimar que el instrumento utilizado (*SERVPERF adaptado*) es fiable²⁴.

La estructura factorial con los 22 ítems, en nuestra muestra, señala 5 factores que explican un 69,83% de la varianza total, superior al 66,8%, con el mismo número de factores extraídos que refiere Díaz R¹¹. La rotación Varimax de nuestros datos muestra una solución satisfactoria que ratifica la validez de constructo del instrumento utilizado.

En cuanto a los contenidos de los ítems que se agrupan en cada factor en nuestros resultados es interesante señalar algunas particularidades:

El factor 1 (que denominamos de atención médica, similar al referido por Díaz con 8 ítems), incorpora el ítem P14.-«*Tiempo dedicado por el personal sanitario*». Esto podría indicar que los participantes interpretan el contenido del ítem con relación al personal médico.

El factor 2 agrupa 6 ítems relacionados con la accesibilidad y los procesos organizativos. De estos 6 ítems, 2 «*tiempo transcurrido para realizar pruebas complementarias y tiempo para ser intervenido quirúrgicamente*», aunque no dependen directamente de atención primaria, se muestran como elementos indiscutibles de percepción de la organización y de la accesibilidad del sistema sanitario.

El factor 3 agrupa los 3 ítems que competen directamente al personal administrativo.

El factor 4 agrupa 2 ítems en los que se valora la apariencia física de los trabajadores del centro (médicos y otro personal).

El factor 5 explica un 5% de la varianza total y está compuesto por 2 ítems (P9 y P11) que refieren amabilidad y preparación del personal de enfermería (atención del personal de enfermería). En el trabajo de Díaz¹¹ estos 2 ítems se agrupan en un mismo factor, muy heterogéneo, con 2 ítems que miden amabilidad y preparación del personal administrativo (P10 y P12).

En nuestro estudio con población usuaria de atención primaria, la estructura factorial que resulta muestra claramente una separación entre los ítems que hacen referencia a enfermería y a personal administrativo. Este resultado es relevante y podría indicar que los pacientes en atención primaria perciben con mayor nitidez la actividad asistencial realizada por la enfermería. En esta línea proponemos en próximas evaluaciones incrementar el número de ítems específicos de enfermería, al menos en igual número que los de personal médico y comprobar si conseguimos, con ellos, alcanzar un mayor porcentaje de varianza total explicada y un factor más robusto para medir la percepción de calidad asistencial de enfermería en atención primaria.

Hemos obtenido una puntuación total media en ($\sum$ 22 ítems = 123). Aunque no hemos encontrado referencias de este valor en otros autores, consideramos que la percepción de calidad es alta, ya que el máximo posible es 154. Nuestros resultados muestran puntuaciones superiores en todos los ítems «mejor percepción de calidad del

servicio», que en el estudio realizado en el distrito de Málaga¹¹.

En la puntuación total media no encontramos diferencias significativas según sexo, tampoco refieren diferencias, otros autores que estudiaron la calidad asistencial en el hospital^{8,25}.

Debemos destacar que en nuestros resultados las mujeres tienen una percepción significativamente mejor que los hombres en aspectos de accesibilidad y organización (factor 2), así como en algunos ítems P5 «seguimiento individualizado que hace el médico del paciente» y en P11 «preparación del personal de enfermería». Las mujeres son las que mejor valoran la accesibilidad, probablemente sea porque son las que mejor conocen el funcionamiento del sistema sanitario.

Algunos estudios^{25,26} mencionan mayor satisfacción a medida que aumenta la edad, nuestros resultados en este sentido indican que con la edad mejora la percepción de la calidad. Solo encontramos diferencias significativas entre los grupos de menor y mayor edad.

Encontramos un porcentaje elevado (69,3%) de pacientes que consideran su salud positiva (buena-muy buena-excelente), cifra similar al 70% que señala la Encuesta Nacional de Salud España 2010, que utiliza como población de referencia la población general adulta (Encuesta N S Española). La percepción del propio estado de salud empeora con la edad de forma significativa, probablemente en relación con una mayor presencia de patologías en las personas de más edad.

La información que nos aportan las preguntas abiertas confirma puntuaciones bajas en algunos ítems, que reflejan poca satisfacción con el personal administrativo. También confirma las altas puntuaciones en otros ítems, como el interés demostrado por los médicos. En otros estudios revisados²³ se refleja la mayor satisfacción con el personal sanitario y la menor satisfacción con el personal administrativo.

Entre las necesidades que detectan los pacientes sobresalen: la necesidad de mejorar la insonorización de las consultas, «algunas veces se oye lo que dicen los pacientes», «más tacto en algunas situaciones a las que los médicos están acostumbrados pero que crean pudor al paciente». También como en otros estudios¹⁵ nuestros pacientes expresan su disconformidad con la demora entre la hora de cita y la hora real de consulta. Los pacientes proponen como solución la contratación de más médicos y establecer un turno de tarde en el centro.

Este trabajo tiene las limitaciones propias de un estudio cuantitativo y consideramos que para profundizar en el estudio de la percepción de la calidad en los servicios de atención primaria se requieren más estudios con enfoques metodológicos complementarios cualitativos y cuantitativos^{3,4,13,27,28}.

En conclusión, el cuestionario *SERVPERF adaptado* por Díaz¹¹ se muestra fiable y válido en atención primaria y los usuarios del centro de salud perciben un servicio sanitario de buena calidad.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Agradecimientos

A los pacientes que han participado, sin ellos no se hubiese podido realizar este estudio. A todos los profesionales del Centro de Salud de Adormideras A Coruña por facilitar la realización de este trabajo, a Soly Santiago, por su apoyo metodológico, y a Begoña Paz-Rey, filóloga que ha revisado el manuscrito y la traducción.

Bibliografía

- Maderuelo Fernández JA. Gestión de la calidad total: el modelo EFQM de excelencia. *Medifam*. 2002;12:41–54 [Revista en Internet] [consultado 03 Sep 2010] Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1131-57682002001000004&script=sci.arttext>
- Rodríguez Orejuela A. Calidad en los servicios de salud en Colombia desde la perspectiva del consumidor: Propuesta de construcción de una escala de medida. *Cuadernos Administración Bogotá (Colombia)*. 2007;20:237–58.
- Correia Loureiro SM, Miranda González FJ. Calidad y satisfacción en el servicio de urgencias hospitalarias: análisis de un hospital de la zona centro de Portugal. *Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa*. 2010;16:27–41.
- Caminal J. La medida de la satisfacción: un instrumento de la participación de la población en la mejora de la calidad de los servicios sanitarios. *Rev Calid Asist*. 2001;16:276–9.
- Castillo Luis, Dougnac Alberto, Vicente Irene, Muñoz Víctor, Rojas Víctor Los predictores de satisfacción de pacientes en un centro hospitalario universitario. *Rev méd Chile*. 2007;135:696–701, <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-988720070006000002> [revista en la Internet] [consultado 02 Abr 2012] Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci.arttext&pid=S0034-988720070006000002&lng=es>
- Bolívar. I. La satisfacción con la atención primaria: factores poblacionales. *Gac Sanit*. 1999;13:371–83.
- Martín Fernández J, Gómez Gascón T, Martínez García-Olalla C, Del Cura González MI, Cabezas Peña MC, García Sánchez S. Medición de la capacidad evaluadora del cuestionario CVP-35 para la percepción de la calidad de vida profesional. *Aten Primaria*. 2008;40:327–34.
- Mateos M, Dierssen-Sotos T, Rodríguez-Cundín MP, Robles-García M, Lorca J. Diferencias en la satisfacción percibida según el sexo en los pacientes ingresados en los hospitales del Servicio Cántabro de Salud. *Rev Calid Asist*. 2009;24:104–8.
- Chang de la Rosa M, Alemán-Lage MC, Cañizares-Pérez M, Ibarra AM. Satisfacción de los pacientes con la atención médica. *Rev Cubana Med Gen Integral*. 1999;15:541–7.
- Martín Zurro A. Sobre la calidad percibida de la atención primaria. *Aten Primaria*. 2005;36:364–6.
- Díaz R. La calidad percibida en la sanidad pública. *Rev Calid Asist*. 2005;20:35–42.
- Barrasa JI, Aibar C. Revisión sistemática de los estudios de satisfacción realizados en España en el período 1986-2001. *Rev Calid Asist*. 2003;18:580–90.
- Mira JJ, Aranaz J. La satisfacción del paciente como una medida del resultado de la atención sanitaria. *Med Clín (Barc)*. 2000;114 Suppl. 3:26–33.
- Sanjay KJ, Garima G. Measuring service quality: SERVQUAL vs. SERVPERF scales. *Vikalpa*. 2004;29, 2.
- Nebot Adell C, Baqués Cavallé T, Crespo García A, Canela Soler J. La opinión de los usuarios como oportunidad de mejora en atención primaria. *Aten Primaria*. 2005;35:290–4.
- Gené Badia J. Decidiendo juntos ganaremos efectividad. *Aten Primaria*. 2005;35:175–7.
- Barca Fernández I, Parejo Miguez R, Gutiérrez Martín P, Fernández Alarcón F, Alejandro Lázaro G, López de Castro F. La información al paciente y su participación en la toma de decisiones clínicas. *Aten Primaria*. 2004;33:361–4.
- Sánchez Carrión JJ, editor. Introducción a las técnicas del análisis multivariable aplicadas a las ciencias sociales. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas; 1984.
- Comrey AL. Manual de Análisis Factorial. Madrid: Cátedra; 1985.
- Mira JJ, Aranaz J, Rodríguez-Marín J, et al. SERVQHOS: Un cuestionario para evaluar la calidad percibida de la asistencia hospitalaria. *Med Preva*. 1998;IV:12–8.
- De la Fuente-Rodríguez A, Fernández-Lerones MJ, Hoyos-Valencia Y, León-Rodríguez C, Zuloaga-Mendiolea C, Ruiz-Garrido M. Servicio de urgencias de atención primaria: Estudio de calidad percibida y satisfacción de los usuarios de la zona básica de salud Altamira. *Rev Calid Asist*. 2009;24:109–14.
- Magro-Peteguer R. Expectativas y satisfacción de los usuarios de Atención Primaria. *Semergen*. 1998;24:711–8.
- Raña Lama CD, Gómez-Besteiro MI, Vaamonde García P.v Satisfacción dos usuarios de Unidades de Atención Primaria de Saúde. *Cad Aten Primaria*. 1998;5:237–40.
- Fernández San Martín MI, Rebagliato Nadal O, De Gispert Uriach B, Roig Carrera H, Artigas Guix J, Bonay Valls B, et al. Adaptación de un cuestionario de satisfacción del paciente con la consulta médica y de enfermería. *Aten Primaria*. 2008;40:611–6.
- Pujiula-Masó J, Suñer-Soler R, Puigdemont-Guinart M, Grau-Martín A, Bertrán-Noguer C, Hortal-Gasull G, et al. La satisfacción de los pacientes hospitalizados como indicador de la calidad asistencial. *Enferm Clin*. 2006;16:19–26.
- Santiñá M, Prata A, Martínez G, Llorenç Quintó A, Asenjo MA. Influencia de la edad del paciente en la percepción de la calidad asistencial. *Rev Calid Asist*. 2004;19:238–42.
- Palacio F, Marquet R, Oliver E, Castro P, Bel M, Piño JL. Las expectativas de los pacientes: ¿qué aspectos valoran en un centro de salud? un estudio cuali-cuantitativo. *Aten Primaria*. 2003;31:307–14.
- Redondo Martín S, Bolaños Gallardo E, Almaraz Gómez A, Maderuelo Fernández JA. Perceptions and expectations on primary health care: a new form of identifying improvements in the care system. *Aten Primaria*. 2005;36:364–6.